



Ministério da Saúde

Urgencia Nº: XX Data Urg.: xx-xx-xxxx xx:xx:xx
Proc.: XXXX Identificação N. Utente: XXXX
Nome: XXX
Data Nasc.: XX/XX/XXXX (XX Anos) Prof XXXX Sexo: XXX
Morada: XXXX
Localidade: XXXX Telefone: XXXX

Médico Família

Centro de Saúde: XXXXX
Médico: XXXXXX

Outros Dados

Causa : XXXXXX Proveniência: XXXXXx
Subsistema: XXXXXX
Observações: XXXX

Triagem

Data / Hora da Triagem: XXXXX
Discriminador: xxxxx

Fluxograma : XXXX

Prioridade Clínica

Temperatura: Dor: XX

Glasgow: XXXXX

PEFR: Freq. Resp.: PA: /

Glicémia: Corpos cetónicos: Freq. card.: Ritmo de pulso:

Oxi. per.:

Mobilidade: XXXXXx

Especialidade: XXXXX Grupo: XXXXX Sala: XXXX

Queixa: XXXXX

Justificação Via Verde:

Triador: XXXXXXXX Nº. Mecanográfico: XXXX Ass.: _

Observações Médicas

14-Jan-2026 16:42:00 Dr(a). Luís Miguel Tavares (HUC-URG_MEDICA)

Homem, 71 anos, recorre por agravamento da dispneia habitual c/ 2 dias evolução, associado a aumento da tosse produtiva e expectoração mais abundante, amarelada/esverdeada. Sem hemoptises. Nega dor torácica, ortopneia, DPN, edemas MMII, síncope ou palpitações. Sem febre quantificada, arrepios ou prostração marcada. Refere utilização mais frequente de salbutamol SOS, c/ alívio incompleto. Sem contacto conhecido c/ doentes respiratórios. Sem internamentos recentes ou antibioterapia nos últimos 3 meses.

AP: DPOC moderada; ex-fumador, 40 UMA, cessação 2019. DM2, HTA, adenocarcinoma próstata submetido a prostatectomia radical em 2022, sob hormonoterapia/vigilância. Exacerbação ligeira DPOC em 02/2025, tratada ambulatório. Sem antecedentes de IC ou cardiopatia isquémica conhecidos.

MH: tiotrópio 18 mcg id inalado; salbutamol 100 mcg SOS; metformina 1000 mg 2id; empagliflozina 10 mg id; perindopril 5 mg id; bicalutamida 50 mg id.

Alergia a contraste iodado, urticária ligeira prévia.

À observação: consciente, colaborante, orientado, discurso em frases completas, sem utilização marcada de musculatura acessória. Polipneia ligeira em repouso. TA 138/76 mmHg, FC 96 bpm, FR 22 cpm, T 37,2°C, SpO2 92% AA, glicemia capilar 184 mg/dL. Corado, hidratado, sem cianose central. Sem ingurgitamento jugular. AC: tons rítmicos, sem sopros. AP: MV globalmente diminuído, expiração prolongada, roncos dispersos bilateralmente e sibilância expiratória ligeira, sem fervores crepitantes focais. Sem macicez à percussão. Abdómen mole, depressível, indolor. MMII sem edemas, sem dor ou assimetria gemelar. Sem défices neurológicos focais.

Quadro compatível c/ exacerbação infecciosa ligeira-moderada de DPOC, por aumento de dispneia, volume e purulência da expectoração. Sem critérios clínicos/radiológicos de pneumonia; sem instabilidade hemodinâmica, hipercapnia clínica ou necessidade de O2 suplementar persistente.

Feita nebulização c/ salbutamol + ipratrópio e prednisolona 40 mg VO, c/ melhoria subjetiva da dispneia e diminuição dos roncos/sibilância. Reavaliação: FR 18 cpm, FC 88 bpm, SpO2 94% AA, mantém-se confortável em repouso e deambula sem dessaturação significativa (SpO2 mínima 92% AA).

Alta c/ amoxicilina/ácido clavulânico 875/125 mg 12/12h durante 5 dias, prednisolona 40 mg id durante 5 dias, manter tiotrópio diário e salbutamol 2 puffs 6/6h SOS nos próximos dias. Alertado para possível agravamento transitório de glicemias sob corticoterapia; manter hidratação e vigilância glicémica capilar mais frequente, contactar médico assistente se valores persistentemente >250 mg/dL. Manter restante terapêutica habitual. Reavaliação por Médico de Família/Pneumologia em 48-72h; consulta Pneumologia para otimização de terapêutica inalatória. Explicados sinais de alarme: dispneia em repouso/agravamento, SpO2 <90%, febre persistente, dor torácica, confusão, incapacidade para alimentação/hidratação ou ausência de melhoria em 48h; se presentes, recorrer novamente SU.

Notas de Enfermagem

16:08h – Admitido por dispneia e tosse produtiva. SpO2 92% AA; sem dificuldade marcada na fala. Colhida amostra sanguínea, colocado acesso venoso periférico MSE.

16:25h – Realizada terapêutica inalatória conforme prescrição, bem tolerada, sem reações adversas.

17:18h – Reavaliado após terapêutica: refere melhoria parcial da falta de ar; SpO2 94% AA, sem necessidade de oxigenoterapia.

18:05h – Alta pelo próprio pé, acompanhado por familiar, consciente/orientado. Informação clínica e terapêutica entregue, verbaliza compreensão.

Diagnósticos

(J441) - Exacerbação aguda de DPOC, provável etiologia infecciosa, sem insuficiência respiratória aguda.

(E119) - Diabetes mellitus tipo 2, sem complicações agudas.

(I10) - Hipertensão arterial essencial

Medicação

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco

14/01/2026 16:25 | 14/01/2026 16:25 | 14/01/2026 16:25 | Salbutamol 2,5 mg solução para nebulização

14/01/2026 16:25 | 14/01/2026 16:25 | 14/01/2026 16:25 | Brometo de ipratrópio 0,5 mg solução para nebulização

14/01/2026 16:35 | 14/01/2026 16:35 | 14/01/2026 16:35 | Prednisolona 40 mg VO

MCDT Requisitados / Procedimentos Efectuados

A10021 – Hemograma completo: Hb 14,2 g/dL; Ht 43,1%; eritrócitos $4,71 \times 10^{12}/L$; leucócitos $12,4 \times 10^9/L$, neutrófilos 78,6%/9,75 $\times 10^9/L$, linfócitos 12,8%/1,59 $\times 10^9/L$; plaquetas $248 \times 10^9/L$. Leucocitose neutrofílica ligeira.

A10034 – Bioquímica urgente: glicose 196 mg/dL; ureia 34 mg/dL; creatinina 1,03 mg/dL, TFGe 78 mL/min/1,73m²; Na 137 mmol/L; K 4,4 mmol/L; Cl 101 mmol/L; AST 24 U/L; ALT 29 U/L. Sem lesão renal aguda ou alterações hidroeletrolíticas relevantes.

A10048 – PCR 28 mg/L, elevação discreta; procalcitonina 0,07 ng/mL, sem elevação sugestiva de infeção bacteriana sistémica.

R10830 – RX tórax PA e perfil: campos pulmonares hiperinsuflados, c/ aumento do espaço retroesternal e discreto achatamento diafragmático, compatível c/ DPOC conhecida. Sem focos de condensação alveolar. Sem infiltrado intersticial agudo. Seios costofrénicos livres, sem derrame pleural ou pneumotórax. Silhueta cardíaca sem aumento. Sem alterações agudas ósseas visíveis.

Destino do Doente

Data: 14/01/2026 18:10

Destino: Domicílio

Médico: Dr(a). Luís Miguel Tavares